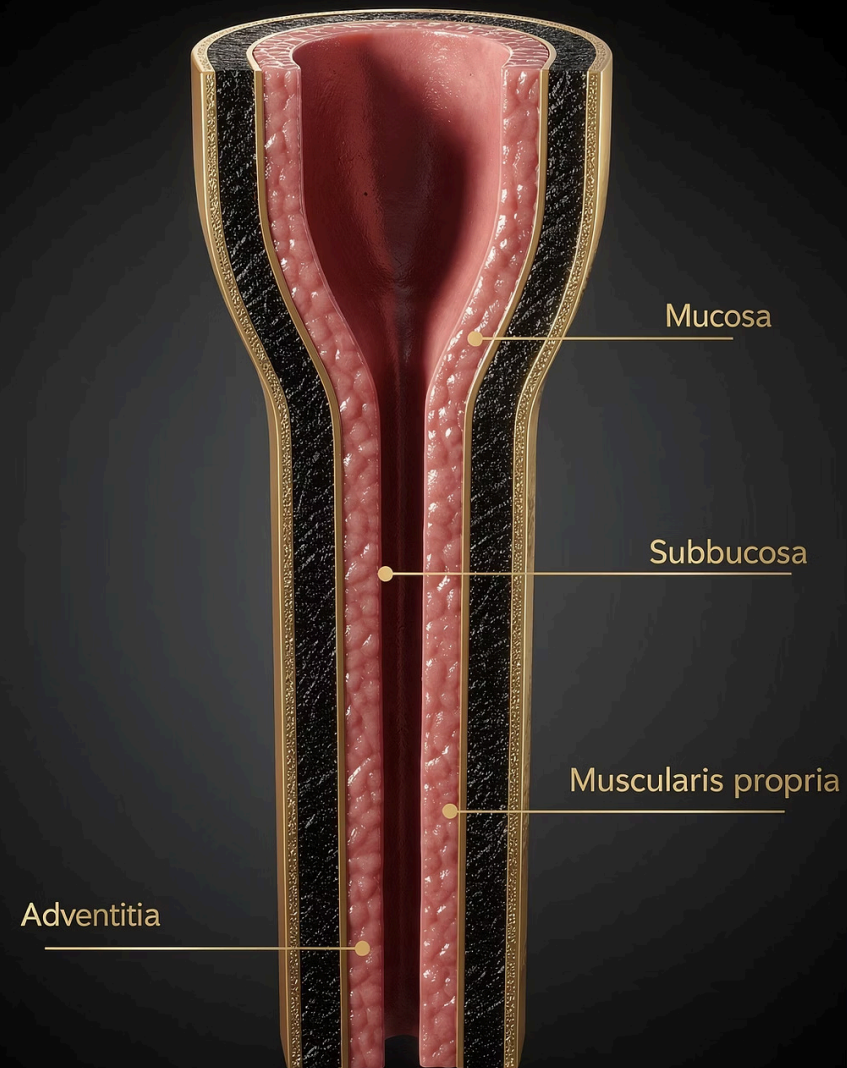


Esofagite Eosinofílica e Distúrbios Motores Esofágicos

Tratamento, Manutenção e Introdução aos Distúrbios da Motilidade — **Apostila 4** ·
Parte Final

GASTROENTEROLOGIA

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA



Tratamento da Esofagite Eosinofílica — Os Três Pilares

A abordagem terapêutica da Esofagite Eosinofílica (EEO) é multifacetada e deve ser individualizada conforme o perfil clínico do paciente. O tratamento se estrutura em três pilares complementares, que podem ser usados isoladamente ou em combinação, dependendo da gravidade da doença, da faixa etária e da resposta inicial.

1. Terapia Dietética

Exclusão dos alimentos desencadeadores da resposta imunológica. Estratégia de primeira linha, especialmente eficaz em crianças e jovens adultos.

2. Terapia Medicamentosa

Uso de IBP e corticoides tópicos deglutidos para redução da inflamação mucosa e alívio dos sintomas funcionais.

3. Terapia Endoscópica

Dilatação esofágica indicada nos casos de estenose significativa com disfagia importante, como medida paliativa sintomática.

O objetivo unificador das três abordagens é: **reduzir a inflamação eosinofílica**, **melhorar os sintomas clínicos** (em especial a disfagia) e **prevenir complicações** estruturais como a fibrose e o estreitamento esofágico. A escolha da estratégia deve considerar a adesão do paciente, a disponibilidade do recurso e o contexto clínico.

Tratamento Dietético da EEO

A terapia dietética baseia-se na exclusão de alimentos que desencadeiam a resposta imunológica Th2 na mucosa esofágica. É uma estratégia eficaz, especialmente em crianças, e pode evitar completamente o uso de medicamentos em uma parcela significativa dos pacientes.

Estratégias Dietéticas

1 Dieta Elementar

Uso de fórmulas aminoacídicas totalmente hidrolisadas. Máxima eficácia, mas baixa adesão por palatabilidade reduzida.

2 Dieta de Exclusão dos 6 Alimentos

Retirada empírica dos seis principais grupos alergênicos. Abordagem mais prática e amplamente utilizada na prática clínica.

3 Dieta Guiada por Testes Alérgicos

Personalizada com base em resultados de prick test ou patch test. Menor restrição, porém com acurácia variável.

Os 6 Alimentos Mais Envolvidos



Leite de Vaca

Principal gatilho em crianças. Proteínas como caseína e whey são fortemente alergênicas.



Ovo

Segunda causa mais frequente. Tanto clara quanto gema podem ser implicadas.



Trigo, Soja, Amendoim e Frutos do Mar

Completam os seis principais grupos. A reintrodução sequencial permite identificar o alimento responsável.

Por Que o Tratamento Alimentar É Tão Importante?

A terapia dietética merece destaque especial na condução da EEO por reunir um perfil favorável de eficácia, segurança e potencial de remissão sem o uso de fármacos. Compreender seu papel é fundamental para a tomada de decisão clínica.

Alta Taxa de Resposta Histológica

A dieta de exclusão dos 6 alimentos alcança remissão histológica (definida como menos de 15 eosinófilos por campo de grande aumento) em **60–80% dos pacientes**, taxa comparável ao uso de corticoides tópicos.

Eficácia Superior em Crianças

Em pacientes pediátricos, a resposta é particularmente expressiva. A identificação precoce do alérgeno alimentar e a exclusão dirigida podem levar à remissão completa da doença em muitos casos, evitando medicações crônicas.

Potencial de Evitar Medicamentos

Em contextos em que a terapia farmacológica é de difícil acesso, indesejada pelo paciente ou contraindicada, a abordagem dietética representa uma alternativa terapêutica robusta e sustentável a longo prazo.

Estratégia Diagnóstico-Terapêutica

A reintrodução sequencial dos alimentos após melhora clínica e histológica permite identificar o(s) alérgeno(s) específico(s) de cada paciente, personalizando o manejo e melhorando a qualidade de vida.

Tratamento Medicamentoso da EEO

Quando a terapia dietética não é suficiente ou praticável, o tratamento medicamentoso entra como pilar fundamental no controle da Esofagite Eosinofílica. Duas classes de medicamentos são centrais nessa abordagem.

Inibidores de Bomba de Prótons (IBP)

Os IBP — classicamente usados no tratamento do refluxo — demonstram atividade anti-inflamatória independente de sua ação ácido-supressora. Mecanismos incluem inibição da produção de eotaxina-3 pelas células epiteliais esofágicas, reduzindo o recrutamento de eosinófilos.

- Omeprazol, esomeprazol ou pantoprazol em doses plenas
- Resposta observada em **30–50% dos pacientes**
- Utilizados como primeiro passo medicamentoso, antes de corticoides
- Monitoramento endoscópico após 8–12 semanas de uso

Corticoides Tópicos Deglutidos

Os corticoides tópicos são a principal arma farmacológica da EEO. Devem ser administrados de forma deglutida — e não inalada — para que o fármaco entre em contato direto com a mucosa esofágica.

- **Fluticasona**: spray administrado na boca e engolido, sem inalar
- **Budesonida**: formulada como viscosa (misturada a adoçante) para melhor adesão à mucosa
- Induzem remissão histológica em **até 70% dos casos**
- Efeitos adversos: candidíase esofágica (monitorar)
- Não devem ser usados em nebulização ou inalação convencional

Metas do Tratamento Medicamentoso

O tratamento medicamentoso da EEO possui objetivos terapêuticos claramente definidos que devem guiar as decisões clínicas e o acompanhamento do paciente. A avaliação de resposta é sempre clínica e histológica.



Reduzir a Infiltração Eosinofílica

Meta histológica: atingir menos de **15 eosinófilos por campo de grande aumento** na biópsia de esôfago. Este é o marcador objetivamente mais importante de resposta ao tratamento.



Melhorar a Disfagia

Alívio do principal sintoma da doença, com impacto direto na qualidade de vida, estado nutricional e segurança alimentar do paciente. A resposta sintomática precede a histológica em alguns casos.



Evitar a Fibrose e Remodelamento

A inflamação crônica não tratada leva ao remodelamento submucoso com deposição de colágeno, resultando em fibrose e estreitamento luminal permanente. O tratamento precoce e contínuo é essencial para prevenir esta progressão irreversível.



⚠ Ponto clínico essencial: A melhora sintomática isolada não garante remissão histológica. O controle endoscópico com biópsias é indispensável para confirmar a resposta terapêutica real.

Dilatação Esofágica — Terapia Endoscópica na EEO

A terapia endoscópica representa o terceiro pilar no manejo da Esofagite Eosinofílica e tem papel bem definido, porém **complementar** ao tratamento medicamentoso e dietético.

Indicações Precisas

- **Estenose esofágica estabelecida** com calibre luminal reduzido
- **Disfagia importante e refratária** ao tratamento clínico otimizado
- Impactação alimentar recorrente com risco de complicações agudas
- Anéis esofágicos múltiplos (esôfago em "traqueia") sintomáticos

Técnica Utilizada

A dilatação esofágica é realizada por via endoscópica, utilizando bougies progressivos ou balões de dilatação. A técnica deve ser cuidadosa, com progressão gradual, pois a mucosa friável da EEO aumenta o risco de lacerações e perfuração.

⚠ Limitações Fundamentais

A dilatação esofágica melhora os sintomas, mas não trata a inflamação subjacente.

- Não reduz a infiltração eosinofílica da mucosa
- Não altera a progressão da doença sem tratamento concomitante
- Efeito sintomático temporário sem controle inflamatório paralelo
- Risco de perfuração: maior que em esôfago normal (mucosa friável)
- Deve ser **sempre associada** ao tratamento medicamentoso ou dietético

A dilatação resolve o problema mecânico; o tratamento clínico resolve o problema biológico.

Terapia de Manutenção — Controle Contínuo da EEO

A Esofagite Eosinofílica é uma **doença crônica, recidivante e imunomediada**. Diferentemente de condições com possibilidade de cura definitiva, a EEO requer controle contínuo para evitar recaídas e progressão para complicações estruturais. A descontinuação do tratamento leva à recidiva na grande maioria dos pacientes.

1

Dieta Restritiva Prolongada

Manutenção da exclusão do(s) alimento(s) responsável(is) identificado(s) durante a fase de indução. Reavaliações periódicas com reintrodução supervisionada para verificar tolerância.

2

Corticoides Tópicos em Dose Reduzida

Uso contínuo de fluticasona ou budesonida em doses de manutenção. Monitorar candidíase esofágica como efeito adverso principal. Endoscopia de controle a cada 1–2 anos.

3

IBP como Adjuvante

Inibidores de bomba de prótons podem ser mantidos como parte do esquema de manutenção, especialmente quando há sobreposição com DRGE ou em pacientes respondedores.

  **Dado crucial:** Estudos mostram que a suspensão do tratamento leva à recidiva histológica em **mais de 80% dos pacientes em 3–6 meses**. A manutenção não é opcional — é parte essencial do plano terapêutico.

Evolução Sem Tratamento — Consequências da EEo Não Controlada

A história natural da Esofagite Eosinofílica sem tratamento adequado é progressiva e pode levar a consequências estruturais graves e irreversíveis. A compreensão dessas complicações reforça a urgência do diagnóstico precoce e do manejo contínuo.

Fibrose Progressiva da Submucosa

A inflamação eosinofílica crônica ativa fibroblastos e miofibroblastos, com deposição progressiva de colágeno na lâmina própria e submucosa. Este processo é **irreversível** e independente da atividade inflamatória atual.

Estreitamento Luminal do Esôfago

A fibrose resulta em redução do diâmetro luminal, levando a estenoses segmentares ou difusas. O esôfago pode assumir aparência de "traqueia" com anéis circunferenciais múltiplos, característica endoscópica patognomônica.

Impactação Alimentar Recorrente

Com o estreitamento progressivo, episódios de impactação alimentar (geralmente por carnes ou pão) tornam-se frequentes, exigindo remoção endoscópica de urgência. Cada episódio aumenta o risco de perfuração e complicações agudas.

EEO vs DRGE — Diferenciação Clínica Essencial

A distinção entre Esofagite Eosinofílica e Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é um dos diagnósticos diferenciais mais importantes na gastroenterologia. Ambas afetam o esôfago e podem apresentar sobreposição clínica, mas possuem fisiopatologias, tratamentos e prognósticos completamente distintos.

Característica	Esofagite Eosinofílica (EEO)	DRGE
Eosinófilos/campo	≥ 15 (critério diagnóstico)	< 7 (achado inconstante)
Localização da lesão	Esôfago médio e proximal	Esôfago distal (junção EG)
Sintoma predominante	Disfagia (progressiva)	Pirose e regurgitação
Mecanismo	Imunológico — hipersensibilidade Th2	Mecânico — exposição ao ácido
Associação	Atopia, asma, rinite alérgica	Obesidade, hérnia hiatal
Resposta ao IBP	Parcial (~30–50%)	Boa (> 80%)
Tratamento principal	Dieta + corticoides tópicos	IBP + modificações de estilo de vida

  **Nota importante:** Existe um subgrupo denominado "EEO responsiva ao IBP" — pacientes com histologia de EEO que respondem ao IBP. Este grupo pode representar fenótipos sobrepostos ou mecanismos de ação anti-inflamatória dos IBP independentes da supressão ácida.



NOVO CAPÍTULO

Introdução aos Distúrbios Motores Esofágicos

Os distúrbios motores esofágicos representam um grupo heterogêneo de condições caracterizadas por **alterações na coordenação, força ou sequenciamento das contrações musculares do esôfago**. Afetam o transporte eficiente do bolo alimentar da faringe ao estômago, resultando em sintomas que podem ser debilitantes e de difícil diagnóstico.



O Que São?

Falhas na coordenação neuromuscular do esôfago que comprometem a progressão ordeira do alimento, causando disfagia, dor torácica ou regurgitação.



Mecanismo Básico

Envolvem disfunção do sistema nervoso entérico local, do sistema nervoso autônomo ou da própria musculatura lisa e estriada do esôfago.



Relevância Clínica

São causas frequentemente subdiagnosticadas de disfagia e dor torácica não cardíaca, condições que representam desafio diagnóstico significativo na prática médica.

Fisiologia da Motilidade Esofágica Normal

Para compreender os distúrbios motores, é essencial dominar a fisiologia da motilidade normal do esôfago. O transporte esofágico é um processo altamente coordenado que envolve três componentes integrados.



Peristalse Coordenada

Contração sequencial progressiva do corpo esofágico, iniciada no esôfago proximal e propagando-se em direção distal. A velocidade e a amplitude das ondas são reguladas pelo plexo mioentérico.



Relaxamento do EEI

O Esfíncter Esofágico Inferior (EEI) deve relaxar coordenadamente com a onda peristáltica. Esse relaxamento é mediado pela inervação inibitória do plexo mioentérico (VIP e NOS).



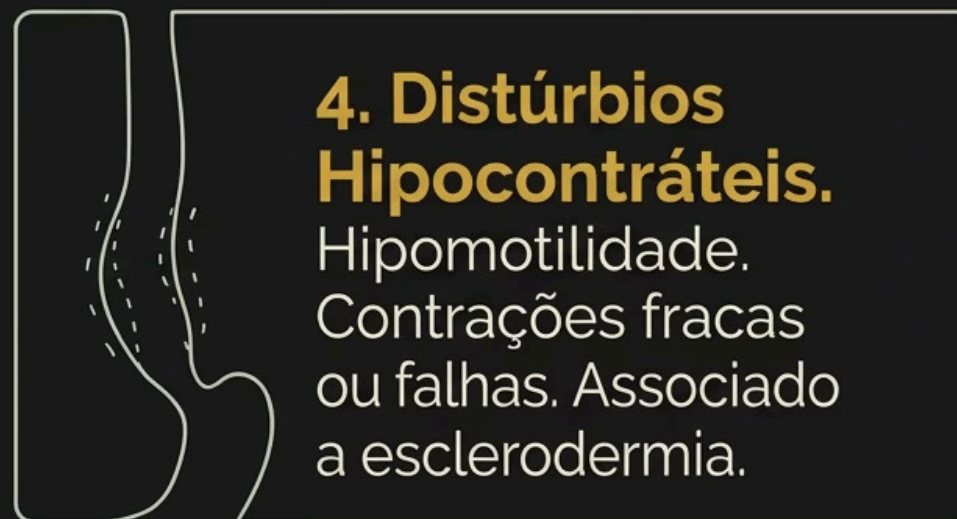
Integração Neural

O eixo cérebro-intestino coordena a resposta motora esofágica. O núcleo motor dorsal do vago integra os sinais aferentes e eferentes que regulam toda a sequência motora.

Qualquer falha em um desses três componentes resulta em **disfagia** — sintoma cardinal dos distúrbios motores esofágicos. A disfagia motora classicamente ocorre tanto para sólidos quanto para líquidos, diferenciando-se da disfagia mecânica (obstrutiva), que tipicamente se inicia com sólidos.

Tipos de Distúrbios Motores Esofágicos

A classificação moderna dos distúrbios motores esofágicos é baseada nos achados da **Manometria de Alta Resolução (MAR)** com o sistema Chicago Classification (versão 4.0). Os distúrbios são agrupados em categorias funcionalmente distintas.



A Acalasia é o distúrbio motor primário mais estudado e clinicamente relevante. Os demais representam espectros de disfunção que podem ser primários ou secundários a doenças sistêmicas como esclerodermia, diabetes mellitus e amiloidose.

Acalasia — Visão Geral e Fisiopatologia

A Acalasia é o distúrbio motor primário do esôfago mais importante e melhor caracterizado. Sua compreensão é fundamental para o médico especialista em gastroenterologia.

Definição Precisa

A Acalasia é definida pela combinação de dois achados manométricos obrigatórios:

- **Falha no relaxamento do EEI:** pressão de relaxamento integrada (IRP) elevada na MAR
- **Ausência de peristalse:** aperistalse do corpo esofágico

É considerada uma **doença funcional grave** por comprometer profundamente a qualidade de vida e o estado nutricional do paciente.

Fisiopatologia

- **Degeneração do plexo mioentérico** (plexo de Auerbach) — mecanismo central
- Perda seletiva dos **neurônios inibitórios** (que produzem VIP e NOS)
- Manutenção relativa dos neurônios excitatórios colinérgicos
- **Predomínio de contração tônica** do EEI por ausência de inibição adequada
- Aperistalse do corpo por desequilíbrio excitatório-inibitório

A causa da degeneração neuronal é multifatorial — possível mecanismo autoimune, infeccioso (*Trypanosoma cruzi* na Doença de Chagas) ou idiopático.

Acalasia — Manifestações Clínicas e Diagnóstico

O quadro clínico da Acalasia é característico e, quando reconhecido, orienta diretamente para a investigação diagnóstica apropriada. O diagnóstico é confirmado pela integração de dados clínicos, radiológicos e funcionais.

Manifestações Clínicas

→ Disfagia Progressiva para Sólidos e Líquidos

Sintoma cardinal. A disfagia **tanto para sólidos quanto para líquidos** desde o início é um marcador importante de causa funcional (motora), diferenciando da disfagia mecânica que começa pelos sólidos.

→ Regurgitação de Alimentos Não Digeridos

Retorno de alimentos retidos no esôfago dilatado. Risco de broncoaspiração, especialmente à noite, podendo causar pneumonias aspirativas recorrentes.

→ Perda de Peso e Dor Torácica

Perda ponderal por ingestão reduzida e dificuldade alimentar progressiva. Dor torácica retroesternal, especialmente nas formas hipercontráteis (Acalasia Tipo III).

Diagnóstico — Exames Essenciais

01

Manometria de Alta Resolução (MAR)

Padrão-ouro diagnóstico. Evidencia IRP elevada e aperistalse. Permite subclassificação em tipos I, II e III pelo sistema Chicago, com implicações terapêuticas diretas.

02

Esofagograma Baritado

Imagem clássica em "**bico de pássaro**" (bird-beak): estreitamento afilado na junção esofagogástrica com dilatação do corpo esofágico acima. Sinal de Hurst positivo.

03

Endoscopia Digestiva Alta

Fundamental para **excluir causas secundárias** (pseudoacalasia por neoplasia). Pode mostrar esôfago dilatado com resíduo alimentar e resistência ao avanço do aparelho pela JEG.

Tratamento da Acalasia — Opções Terapêuticas

O tratamento da Acalasia visa eliminar a obstrução funcional ao esvaziamento esofágico, reduzindo a resistência do EEI. Não existe terapia que restaure a peristalse perdida — portanto, o objetivo é **facilitar a passagem do alimento por gravidade e pressão**.

1

Dilatação Pneumática

Procedimento endoscópico com balão de alta pressão que distende forçadamente o EEI, rompendo fibras musculares. Eficácia de 60–85%, com necessidade de repetição em 30–50% dos casos em 5 anos. Risco de perfuração ~3%.

2

Miotomia de Heller (Cirúrgica)

Secção cirúrgica (laparoscópica) das fibras musculares do EEI. Gold standard cirúrgico com eficácia de 85–90%. Deve ser associada a funduplicatura parcial para prevenir DRGE pós-operatória.

3

POEM — Per-Oral Endoscopic Myotomy

Miotomia endoscópica por via oral. Técnica minimamente invasiva com eficácia comparável à cirurgia (>90%). Vantagem adicional: acesso ao músculo esofágico proximal (importante no Tipo III). Sem necessidade de incisão abdominal.

4

Toxina Botulínica Intraesfincteriana

Injeção endoscópica de botox no EEI para redução transitória do tônus. Eficácia temporária (6–12 meses), indicada em pacientes idosos, com alto risco cirúrgico ou como ponte terapêutica.

Outros Distúrbios Motores Esofágicos

Além da Acalasia, o espectro dos distúrbios motores esofágicos inclui condições com perfis clínicos e manométricos distintos, que exigem reconhecimento e abordagem específicos.

Espasmo Esofágico Difuso (EED)

Caracterizado por **contrações prematuras e descoordenadas** do corpo esofágico com preservação do relaxamento do EEI. Na MAR: $\geq 20\%$ de contrações prematuras (DCI > 450 mmHg/cm/s). Manifesta-se como **dor torácica intensa** (pode simular angina) e disfagia intermitente. O esofagograma pode mostrar o clássico "esôfago em saca-rolha".

Esôfago Hipercontrátil (Esôfago Martelador)

Contrações de **amplitude muito elevada** (DCI > 8.000 mmHg/cm/s) com peristalse preservada e relaxamento do EEI normal. Causa dor torácica significativa e disfagia. Pode ser associado ao uso de opioides, que aumentam a contratilidade esofágica.

Hipomotilidade / Distúrbios Hipocontráteis

Contrações de **amplitude insuficiente** para propulsão eficaz do bolo alimentar (DCI < 450 mmHg/cm/s em $\geq 50\%$ das deglutições). Causa sintomas de disfagia leve e regurgitação. Frequentemente associado a doenças sistêmicas como **esclerodermia**, **diabetes mellitus**, **hipotireoidismo** e uso de bloqueadores de canais de cálcio.

Relevância Clínica dos Distúrbios Motores — Por Que Diagnosticar Corretamente?

Os distúrbios motores esofágicos representam um desafio diagnóstico de alta relevância clínica porque seus sintomas se sobrepõem com múltiplas outras condições, levando frequentemente a erros terapêuticos e impacto negativo na qualidade de vida do paciente.

Condições que os Distúrbios Motores Simulam

Doença Cardíaca / Angina

O espasmo esofágico causa dor retroesternal intensa que pode ser idêntica à dor coronariana. Até 30% dos pacientes com dor torácica não cardíaca têm distúrbio motor esofágico.

DRGE / Esofagite por Refluxo

Pirose e regurgitação também estão presentes em distúrbios motores. O diagnóstico diferencial exige pHmetria + manometria, pois o tratamento é completamente diferente.

Esofagites Inflamatórias

A disfagia da EEO e dos distúrbios motores pode ser clinicamente semelhante. A endoscopia com biópsias e a MAR são essenciais para diferenciação.

Consequências do Erro Diagnóstico

- **Tratamento inadequado:** uso de antianginosos, IBP ou corticoides sem indicação
- **Procedimentos desnecessários:** cateterismo cardíaco, coronariografia em pacientes com espasmo esofágico
- **Progressão da doença:** acalasia não tratada evolui para megaesôfago com risco aumentado de carcinoma espinocelular
- **Impacto nutricional:** disfagia não tratada leva a desnutrição, sarcopenia e piora do estado geral
- **Risco de aspiração:** regurgitação de acalasia não tratada causa pneumonias aspirativas recorrentes

  **Princípio clínico:** Em todo paciente com dor torácica não cardíaca ou disfagia de causa incerta, a avaliação esofágica com endoscopia e manometria de alta resolução deve ser mandatória.

Mapa Integrado do Conhecimento — Apostila 4 Completa

Esta apostila cobriu um espectro completo da patologia esofágica inflamatória e funcional. A integração desses conhecimentos forma uma base sólida para a prática clínica especializada em gastroenterologia.



O domínio dessas condições permite ao especialista em formação conduzir com segurança desde o raciocínio diagnóstico inicial até a escolha terapêutica mais adequada para cada perfil de paciente.

Conclusões e Mensagens-Chave da Apostila 4

Ao concluir este módulo, o médico residente em especialização deve ter assimilado um corpo de conhecimento robusto e clinicamente aplicável sobre doenças inflamatórias e motoras do esôfago.

✓ EEO é Crônica e Requer Manutenção

A Esofagite Eosinofílica não tem cura definitiva. O tratamento de manutenção — dietético ou farmacológico — é obrigatório para prevenir recidiva (>80% sem manutenção) e complicações fibróticas.

✓ Os Três Pilares Terapêuticos São Complementares

Dieta, medicamentos e endoscopia devem ser integrados conforme o perfil do paciente. A dilatação trata o sintoma; o tratamento clínico trata a doença.

✓ Acalasia Exige Diagnóstico Funcional

A manometria de alta resolução é insubstituível para confirmar acalasia e subtipificá-la (I, II, III). Cada subtipo tem implicações terapêuticas e prognósticas distintas.

✓ Distúrbios Motores Simulam Outras Doenças

Manter alto índice de suspeição para patologia esofágica funcional em pacientes com dor torácica não cardíaca e disfagia de causa incerta é uma competência essencial do especialista.